



裝置心臟節律器 | 生活注意事項

心跳太慢或停頓時，節律器送出微小電流，幫心臟規律跳動

它是心臟的「備用小幫手」，只在需要時出手，不會取代心臟



掃描看電子版

為什麼需要裝節律器？



心跳太慢或會停一下

例如病竇症候群、房室傳導阻滯



改善心跳慢造成的不舒服

頭暈、昏倒、喘、累、沒力氣

目標是預防昏倒與意外、維持安全的心跳；是否需要裝由心臟科醫師評估。

現在有兩種節律器

目標一樣，差別在有沒有導線、傷口在哪裡



傳統節律器（有導線）

機器放鎖骨下皮下，導線經血管進心臟
胸前有傷口與小凸起，術後手臂要限制
使用最久、資料最完整；可做雙腔與 CRT



無導線節律器（膠囊型）

膠囊大小，經鼠蹊部血管直接放進心臟
胸前沒有傷口與導線，外觀看不出來
健保限定條件給付，多數需自費

傷口這樣照顧



保持清潔乾燥

換藥與洗澡方式依醫療團隊指示



不要摳抓、不自己塗藥

傷口癒合前不泡澡、不游泳



每天看一次傷口

注意紅、腫、熱、痛、流湯或裂開

這些要盡快聯絡醫療團隊

發燒、流膿或出血不止、腫脹變大

回家後注意事項



手臂適度活動

有導線者三個月內別高舉過肩或提重物



隨身帶節律器識別卡

看病、看牙、做檢查前主動告知



按時回診檢查節律器

術後約 1 個月、3 個月，之後定期

可能會安排遠距監測

部分裝置能在家把資料傳回醫院

生活中的電器與環境

這些可以正常使用

手機（別放同側胸前口袋，用對側接聽）

微波爐、家電、電腦；電磁爐距離 60 公分

機場安檢：出示識別卡，請改人工檢查

這些一定要先告知

核磁共振 MRI：多數新裝置可做，但須由

團隊事前設定；電燒、電療、碎石術也一樣

避開：電焊、強力磁鐵、大型工業馬達

電池可以用多久？

兩種都約可用 8~12 年，每次回診檢查電量；快沒電會提早幾個月通知，不會突然停掉。

提醒：節律器負責「不要太慢」，不能預防心肌梗塞或中風，原本的藥還是要照吃。

昏倒、胸痛、呼吸困難、持續心悸，或傷口大量出血：立即打 119

資料來源（查核至 2026-09）：

2021 ESC Guidelines on Cardiac Pacing and CRT；2018 ACC/AHA/HRS Bradycardia Guideline；

2025 ACC/AHA/HRS Appropriate Use Criteria for ICD, CRT and Pacing；中央健保署自付差額特材公告。

本單張提供一般衛教，不取代個別診療；實際限制、適用裝置與費用請依您的醫療團隊說明。

A5 直式 | 裝置心臟節律器病人衛教 | © 2026 林祐騰醫師 編製